

Fecha Última Actualización: 30-03-2023 17:42:08

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Vaitiare Romané Guzmán Lagos
Edad : 32a 4m 21d
Dirección : Junquillar 3459 Villa Los Naranjos

Rut : 17.778.424-9
Fecha Nacto: 09/11/1990
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2117228
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 4050 5585

N° Epicrisis
347524

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Neurología / Neurocirugía
Unidad de Egreso : Neurología / Neurocirugía

Fecha Ingreso : 07/03/2023 04:05
Fecha Egreso : 30/03/2023 10:00

Días Estadía: 23

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Cranioplastia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

ANTECEDENTES GENERALES

- AM: infarto maligno de ACM izquierda con transformación hemorrágica. Lesión de carótida izquierda por arma blanca. Neumomediastino por arma blanca. TEP. Encefalopatía tóxica metabólica. NAVM. Síndrome disfágico.

- AQx: Hemicraniectomía descompresiva izquierda

- Fármacos:

Olanzapina 10mg, un comprimido cada 12 horas

Risperidona 1 mg, un comprimido cada 8 horas

Sertralina 50 mg, un comprimido al día

Donepezilo 10 mg, 1/2 comprimido en la noche

Amantadina 100 mg, 2-0-1 comprimidos

Melatonina 3 mg, un comprimido en la noche

Bromuro Ipratropio 20 mcg/dosis, 2 puff según necesidad

Omeprazol 20 mg, un comprimido al día

Polietilenglicol 17 gramos en 200 cc de agua cada 8 horas, para 1-2 deposiciones diarias

Enoxaparina 40 mg subcutánea al día

- Alergias: Ninguna.

HISTORIA ACTUAL

Hemicraniectomía descompresiva post infarto maligno de ACM izquierda. Ingresó por Obs. colección subgaleal. Aparentemente en su basal funcional.

EVOLUCIÓN

Neuroquirúrgico: Cranioplastia realizada el 24/03. Evolución clínica favorable. TC de encéfalo post quirúrgico sin complicaciones. En condiciones de traslado a HSJM para continuar rehabilitación.

Manejo: Activo

Diagnóstico de Egreso

Craneoplastia -

Fecha Epicrisis : 30/03/2023 17:42

Página 1 de 2

Fecha Última Actualización: 30-03-2023 17:42:08

Página 2 de 2

Condición de Egreso Alta Derivado al Hospital San José de Maipo

Egreso con Catéter Doble J: NO

Vigil, afasia de expresión, se comunica principalmente con gesto de mano izquierda, obedece órdenes complejas.
Hemiparesia FBC derecha secuelar.
Edema periorbitario en OI en regresión
Abdomen blando, depresible, indoloro
Parches limpios y secos

Plan Post Alta

Reposo relativo.
Régimen común.
Rehabilitación multimodal: KNT y FNA al menos 3 veces al día.
No mojar la herida. Retiro de parches 10 días posterior a cirugía. Luego de eso lavado de pelo con shampoo hipoalergénico.
Secar región quirúrgica con secador de pelo frío.
Fármacos:
- Olanzapina 10mg, un comprimido cada 12 horas.
- Risperidona 1 mg, un comprimido cada 8 horas.
- Sertralina 50 mg, un comprimido al día.
- Donepezilo 10 mg, 1/2 comprimido en la noche.
- Amantadina 100 mg, 2-0-1 comprimidos.
- Melatonina 3 mg, un comprimido en la noche.
- Bromuro Ipratropio 20 mcg/dosis, 2 puff según necesidad.
- Omeprazol 20 mg, un comprimido al día.
- Polietilenglicol 17 gramos en 200 cc de agua cada 8 horas, para 1-2 deposiciones diarias.
- Paracetamol 500 mg, dos comprimidos cada 8 horas por 5 días.
- Enoxaparina 40 mg subcutánea al día.
Exámenes pendiente: TC de encéfalo sin contraste.
Control con Dr. Kraudy en dos semanas más, lunes 10/04, CDT pasillo 9, sobrecupo AUTORIZADO.
Se explican síntomas y signos de alarma.

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

José Tomás Cárdenas Mardones
Becado/Residente

Médico Tratante (Staff)